



## جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) \* طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هاله حسن العزب صالح  
المحافظة : الغربية  
الحى / المدينة : السنطة  
العنوان : -  
رقم البطاقة : 27009231601723 رقم التليفون : 01028764724  
العمر (تاريخ الميلاد) : 23-09-1970 المهنة : ربه منزل  
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

### الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-  
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة  
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك  
الإحصائي الاجتماعي  
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه  
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الفقرات الصدرية بالصبغة  
قسم العلاج :  
الأورام

[12771]

التعليق على التشخيص : -----

### تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني  
الاسم : د/ندى حسن  
الاسم : د/نرمين رمضان  
الوظيفة :  
الوظيفة :  
الوظيفة :  
التوقيع :  
التوقيع :  
التوقيع :  
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس  
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.  
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.  
تعتمد صحة البيانات المرفقة  
رئيس اللجنة ومدير  
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض  
بالمستشفى قبل الصرف.

### أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

### قرار اللجنة

التشخيص النهائي :  
خطة العلاج :  
المستشفى :  
قسم :  
جهة العلاج :  
نفقات :  
ملاحظات :

ختم  
شعار الجمهورية

مدير عام  
مديرية الشؤون الصحية

رئيس  
المجلس الطبي المتخصص

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name:</b> هاله حسن العزب صالح<br><b>National ID:</b> 27009231601723 |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|           |
|-----------|
| تقرير طبي |
|-----------|

|                  |
|------------------|
| السيد            |
| تحية طبية وبعد,, |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| إيماء للطلب المقدم من | بشأن تقرير طبي للمريض |
| بقسم:                 | رقم طبي:              |

|                                          |
|------------------------------------------|
| نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته |
|------------------------------------------|

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تاريخ وساعة الدخول :<br>-- --:-- yyyy-mm-dd | تاريخ وساعة الخروج :<br>PM 01:17 05-07-2026 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

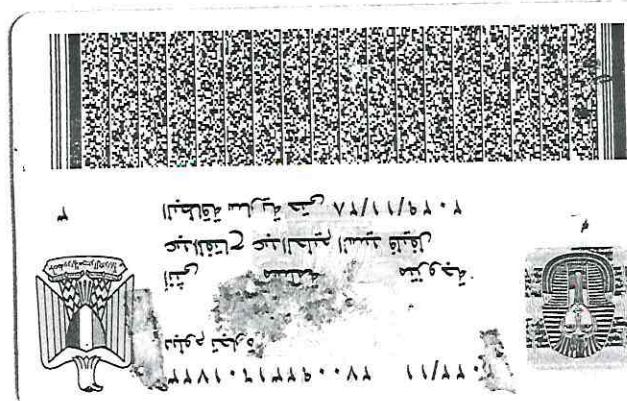
|                                        |
|----------------------------------------|
| وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه |
|----------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي MRI thoracic spine with contrast |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| التاريخ :<br>05-07-2026 | الوقت :<br>-- --:--               |
|                         | الطبيب المعالج :<br>د/شيماء لاشين |



١-١٧٢٣١٦٠١٧٢٣



PATIENT NAME: HALA HASSAN ELAZAB SALEH

GENDER: Female

DATE : 12-Jan-2026 03:15 PM

PATIENT ID: 2021160162  
AGE: 55 y  
ORDER: 3723566,3723567,3724112

## FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY

### INDICATION:

- Screening.

### TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Targeted ultrasound

### FINDINGS:

There are scattered areas of fibroglandular density (ACR b).

### LEFT BREAST:

- Rather stationary UOQ spiculated dense mass, measuring 6.5x6 cm in diameter 15 mm from skin and 5.8cm from the nipple, targeted ultrasound revealed corresponding 2:00 spiculated mass with internal vascularity on color Doppler.
- LOQ small irregular nodule is seen more appreciated in the current study, being 6.5cm inferior to the aforementioned mass and 7cm from nipple, targeted ultrasound revealed corresponding small irregular hypoechoic nodule surrounded with hyperechoic desmoplastic reaction, located at 3:00, measuring about 0.8x0.6cm in diameter.
- Mild areolar and paraareolar skin thickening are still noted with subtle nipple retraction
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.

### RIGHT BREAST:

- No spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- Targeted Ultrasound of outer quadrants revealed no suspicious lesions.
- Scattered round calcifications.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymph nodes.

### OPINION:

- Rather stationary left breast UOQ pathologically proved malignant mass (BIRADS 6) along with LOQ newly appreciated small suspicious nodule.
- Right breast benign findings (BIRADS 2).

PATIENT: HALA HASSAN ELAZAB SALEH, 2021160162, Female, 55 y

Report version 1, 12-Jan-2026 05:19 PM

Page 1 of 2

|        |            |               |                          |
|--------|------------|---------------|--------------------------|
| MRN:   | 202160162  | Patient Name: | HALA HASSAN ELAZAB SALEH |
| D.O.B: | 23/09/1970 | IC No.:       | 27009231601723           |
| Sex:   | Female     | Location:     | External Clinic          |

**SURGICAL PATHOLOGY**  
Biopsy Small - (1 Site)

|              |            |                 |                         |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Specimen Id  | 2107120243 | Collection Date | 12/07/2021 01:05 PM     |
| Accession No | SUR21-5266 | Received Date   | 12/07/2021 01:06 PM     |
| Sample Type  | Tissue     | Doctor          | Abd ALLAH Mohamed Gamil |

**Clinical Information**

Lt. Breast, UOQ mass.  
Gross Picture  
5 cores, 0.5-1.5 cm  
Microscopic Picture  
A case of invasive duct carcinoma, grade II. Stroma is desmoplastic with mild inflammatory cell reaction. There is focal DCIS component, I

**Diagnostic Summary**

Tumour type:  
IDC, grade II

Laterality  
Left

**Specimen type:**

Tru-cut biopsy

Location  
Upper outer quadrant

Histological grade  
Mitosis score (1-5):

2  
Tubular formation score (1-5):

2  
Nuclear grade (1-3):

2  
Histological grade (1-3):

Peritumoural lymphovascular invasion  
Absent

**Diagnosis**

Lt. Breast, tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, grade II.

**Comments**

ER, PR and Her 2 are ordered.

Biopsy reporting category

B5b= Invasive cancer

**Signature**

MONA MOHAMED MAMDOH

Co-signed by:

## Medical Reports

### Patient Information

|              |                                                           |             |                           |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| MRN          | 2021160162                                                | Name        | HALA H/ASSAN ELAZAB SALEH |            |
| ID Type      | الرقم القومي                                              | ID Number   | 27009231601723            |            |
| Gender       | FEMALE                                                    | Nationality | EGYPTIAN                  |            |
| Age          | 55Year(s)                                                 |             |                           |            |
| Written Date | 26/05/2025                                                | 5:16 pm     | Visit Date                | 19/05/2025 |
| Diagnosis    | [P][C50.9] Malignant neoplasm of breast, unspecified part |             |                           |            |

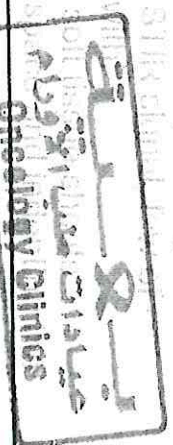
### Report and Recommendation

Postmenopausal 54 ys with MBC ( bone)T4 N2 M1 ,ER:8/8 ,PR 5/8 , Her2: -ve received TAMI/ zoladex from 8/2021 10/2022--> PD--> AC x6--> AI /Zometa 2/2023 Planned for CDK4,6 Inhibitors but was weaved till progression CT CAP 3/2024: stationary course since the last study dated 16/10/2023. Continue AI & Zometa every 3 months, pt reported spotting so Zoladex added again since 5/2/2024 CT CAP: 15/5/2025

stationary course with no newly developed lesions. The examined skeleton shows stationary course as regard:

- Widespread sclerotic osseous lesions.
- Collapsed D3 vertebra seen indenting the cord ( previously irradiated)
- Vertical cleavage of D10 vertebral body.

Bone scan: partial regression of metastatic deposits



### Written By

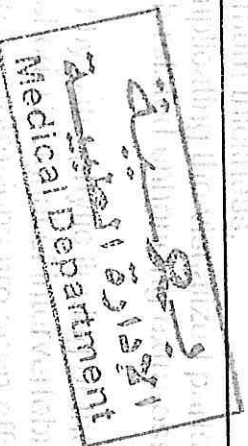
AMIRA

### Approved By

AMIRA Diyaa Abd-Elmoniem DARWISH

Medical Director

د. أميرة ديار عبد المنعم دارويش  
19/05/2025





Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab  
جوستاف روسي انترناتيونال - مصر -معمل الباثولوجي

|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | ملاء حسن العرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

## Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

### Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (4828/23) was received.

### Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;  
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

### Microscopic examination:

-Histologic type: Invasive duct carcinoma.  
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).  
- DCIS: Absent.  
- Micrometastasis: Present.  
- Angiolymphatic invasion: Absent.  
- Perineural invasion: Absent.

### Results:

\* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).  
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).  
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).  
- Ki67%: 15%.

### Conclusion:

Left breast cancer, Block revision:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

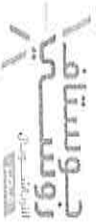
### IPT:

- ER: Positive (score 8/8).  
- PR: Positive (score 6/8).  
- Her2: Ultra low (score 0+).  
- Ki67%: 15%.

شقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر  
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alisar El Qadema - Cairo, Egypt



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab  
 جوستاف رويسى انترناشيونال - مصر -معمل الباثولوجى



|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | مالة حسن الزرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

**\*\*Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**\*\* Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

**Signature**

**Dr. Walaa Ibrahim Choneim, MD.**



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر  
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mhar El Qadima - Cairo, Egypt



د. يوسف  
رئيس  
الفرع  
أ- ٤٢

# مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

المنشأة المصرية  
للطب  
مصر

09/22/2026

## MDT FORM

|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Name:          | هالة حسن الغرب صالحي | MRN:            | 13137          |
| Age:           | 56 Y                 | ID:             | 27009231601723 |
| Menopausal Sta |                      | Phone:          |                |
| NRS SCORE:     |                      | Marital Status: |                |
| BMI:           |                      | Family History: |                |
| CO Morbidity:  |                      | Reason Of MDT:  |                |

## Clinical Data:

|     |         |     |     |       |   |       |    |
|-----|---------|-----|-----|-------|---|-------|----|
| BX: | IDC GII |     |     |       |   |       |    |
| ER: | 8/8     | PR: | 6/8 | HER2: | 0 | KI67: | 15 |

## Sonomammography:

## Mets Workup:

## History:

55 years old female patient, pre menopausal received tam + zoladex from 8/2021 to 11/2022 >> PD. received AC\*6 with regression then kept on maintenance AI + zometa from 2/2023 to 1/2026.

ct cap 1/2026 + bone scan >> SD but clinically progressed with severe back pain

MRI cervical >> multiple vertebral osseous lesion likely mets with c5+d3 cord compression

recommendation for faslodex + cdk4/6 inhibitor but not received received palliative RTH to C4>D3

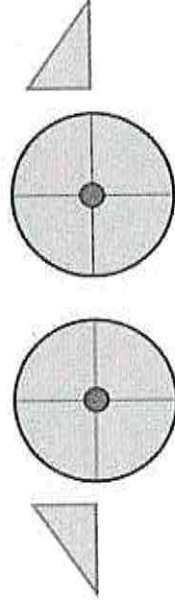
## Recommendations:

shifted to faslodex + ibrance  
ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

## MDT Outcome & Plan

shifted to faslodex + ibrance  
ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

R



TNM

L

## SIGNATURE

|                  |         |           |           |           |             |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| MEDICAL ONCOLOGY | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
| د. محمد كركاش    |         |           |           |           |             |

09/22/2026

1000

## MDT FORM

|                |                    |                 |                |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Name:          | مكة حسن الزرب صالح | MRN:            | 13137          |
| Age:           | 56 Y               | ID:             | 27009231601723 |
| Menopausal Sta |                    | Phone:          |                |
| NRS SCORE:     |                    | Marital Status: |                |
| BMI:           |                    | Family History: |                |
| CO Morbidity:  |                    | Reason Of MDT:  |                |

**Clinical Data:**

**R**

100

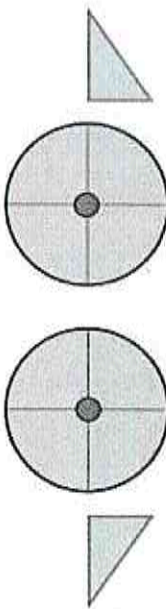
IDC GII

|            |     |            |     |              |   |              |    |
|------------|-----|------------|-----|--------------|---|--------------|----|
| <u>ER:</u> | 8/8 | <u>PR:</u> | 6/8 | <u>HER2:</u> | 0 | <u>KI67:</u> | 15 |
|------------|-----|------------|-----|--------------|---|--------------|----|

KI67: 15

**Sonomammography:**

**Meets Workup:**



**TNM**

### History:

55 years old female patient, pre menopausal received tam + zoladex from 8/2021 to 11/2022 >> PD. received AC6 with regression then kept on maintenance AI + zometa from 2/2023 to 1/2026.

ct cap 1/2026 + bone scan >> SD but clinically progressed with severe back

**pain**

MRI cervical > multiple vertebral osseous lesion likely mets with c5+d3 cord compression

com

received palliative RTH to C4>D3

rece

**Recommendations:**

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + b

### MDT Outcome & Plan

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + b

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

SIGNATURE

| 2. Medical History | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                    |         |           |           |           |             |

15/10/2015

إسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من ..... بشأن تقرير طبي للمريض: حالة سريرية

بقسم ..... رقم طبي .....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

رصدت أعراضاً منسجمة مع تشخيصه السريري.

حالة سريرية المرض والاعراض والخطوات العلاجية

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يُقصد ،،

17/11/21

بشأن تقرير طبي للمريض: صالح محمد

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج.

Chlorine gas 1000 cc

[illegible]

...

03/05/2020

الطبيب المعالج

يَعْتَمِدُ

اسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشأن تقرير طبي للمريض: جمال محمد حسن

بقسم ..... رقم طبي .....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

وزن 60 كجم وارتفاع 170 سم

عند الفحص

20/10/2023

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يُعتمد ،،

اسم المريض ثلاثي:.....  
رقم الملف:.....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من

بقسم

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

٢١) السيد حسن ولي الدين السيد خالد  
صبري صاها خان فاروق  
+ بالبريد +

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يقتد ،،

|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | ملاء حسن العرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

## Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

### Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (4828/23) was received.

### Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;  
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

### Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Present.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

### Results:

\* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).
- Ki67%: 15%.

### Conclusion:

Left breast cancer, Block revision:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

### IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Ultra low (score 0+).
- Ki67%: 15%.



|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | مالة حسن الزرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

**\*\*Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**\*\* Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

**Signature**
**Dr. Walaa Ibrahim Choneim, MD.**


غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر  
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nhar El Qadima - Cairo, Egypt

09/22/2026

## MDT FORM

|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Name:          | هالة حسن الغرب صالحي | MRN:            | 13137          |
| Age:           | 56 Y                 | ID:             | 27009231601723 |
| Menopausal Sta |                      | Phone:          |                |
| NRS SCORE:     |                      | Marital Status: |                |
| BMI:           |                      | Family History: |                |
| CO Morbidity:  |                      | Reason Of MDT:  |                |

### Clinical Data:

**BX:** IDC GII

**ER:** 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** 0 **KI67:** 15

### Sonomammography:

### Mets Workup:

### History:

55 years old female patient, pre menopausal received tam + zoladex from 8/2021 to 11/2022 >> PD. received AC\*6 with regression then kept on maintenance AI + zometa from 2/2023 to 1/2026.

ct cap 1/2026 + bone scan >> SD but clinically progressed with severe back pain

MRI cervical >> multiple vertebral osseous lesion likely mets with c5+d3 cord compression

recommendation for faslodex + cdk4/6 inhibitor but not received received palliative RTH to C4>D3

### Recommendations:

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

### MDT Outcome & Plan

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

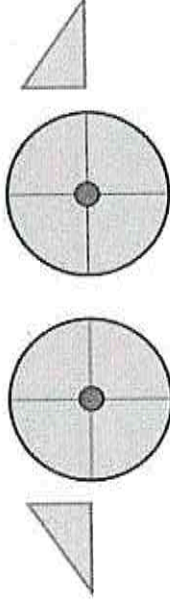
### SIGNATURE

|                  |         |           |           |           |             |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| MEDICAL ONCOLOGY | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
|                  |         |           |           |           |             |

د. محمد كركاشي

R

L



TNM

09/22/2026

1000

## MDT FORM

|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Name:          | مكة صبح الجرب صبح | MRN:            | 13137          |
| Age:           | 56 Y              | ID:             | 27009231601723 |
| Menopausal Sta |                   | Phone:          |                |
| NRS SCORE:     |                   | Marital Status: |                |
| BMI:           |                   | Family History: |                |
| CO Morbidity:  |                   | Reason Of MDT:  |                |

**Clinical Data:**

**R**

100

IDC GII

|            |     |            |     |              |   |              |    |
|------------|-----|------------|-----|--------------|---|--------------|----|
| <u>ER:</u> | 8/8 | <u>PR:</u> | 6/8 | <u>HER2:</u> | 0 | <u>KI67:</u> | 15 |
|------------|-----|------------|-----|--------------|---|--------------|----|

**KI67:** 15

**Sonomammography:**

**Meets Workup:**

### History:

55 years old female patient, pre menopausal received tam + zoladex from 8/2021 to 11/2022 >> PD. received AC6 with regression then kept on maintenance AI + zometa from 2/2023 to 1/2026.

ct cap 1/2026 + bone scan >> SD but clinically progressed with severe back

T N M

pain  
MRI cervical >> multiple vertebral osseous lesion likely mets with c5+d3 cord compression

recommendation for faslodex + cdk4/5 inhibitor but not received  
received palliative RTH to C4>D3

**Recommendations:**

**Recommendations:**

shifted to faslodex + ibranon

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

**MDT Outcome & Plan**

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

**SIGNATURE**

| 2. Medical History | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                    |         |           |           |           |             |

15/10/2015

إسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من ..... بشأن تقرير طبي للمريض: حالة سريرية

بقسم ..... رقم طبي .....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

رصد التهاب حاد في الحنجرة والبلعوم

حالة سريرية التهاب حاد في الحنجرة والبلعوم

د- 15/5/20

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يُقصد ،،

إسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

### تقرير طبي

الميد/.....

تحيةة طبية وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من..... بشأن تقرير طبي للمريض: صالح حبيب

بقسم..... رقم طبي.....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول..... تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

ر/..... سنه..... ولابن..... عملي من شهر سنه

١٤... محرم ١٤٢٨ هـ، فسيحوا وأكثروا الله

محر

د. صالح

تحريراً في

التاريخ: / /

الوقت: .....

الطبيب المعالج

يتمتع،،

اسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشأن تقرير طبي للمريض: جمال محمد حسن

بقسم ..... رقم طبي .....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

وزن 60 كجم وارتفاع 170 سم

عمر 45 سنة

09/12/20

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يُعتمد ،،

اسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من

بقسم

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

٢١) السيد حسن ولي الدين السيد خالد  
صبري صاها خان فاروق  
+ بالبريد +

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يقتد ،،

|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | ملاء حسن العرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

## Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

### Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (4828/23) was received.

### Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;  
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

### Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Present.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

### Results:

\* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).
- Ki67%: 15%.

### Conclusion:

Left breast cancer, Block revision:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

### IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Ultra low (score 0+).
- Ki67%: 15%.



|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | مالة حسن الزرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

**\*\*Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**\*\* Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

**Signature**
**Dr. Walaa Ibrahim Choneim, MD.**


غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر  
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nhar El Qadima - Cairo, Egypt

09/22/2026

## MDT FORM

|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Name:          | هالة حسن الغرب صالحي | MRN:            | 13137          |
| Age:           | 56 Y                 | ID:             | 27009231601723 |
| Menopausal Sta |                      | Phone:          |                |
| NRS SCORE:     |                      | Marital Status: |                |
| BMI:           |                      | Family History: |                |
| CO Morbidity:  |                      | Reason Of MDT:  |                |

### Clinical Data:

**BX:** IDC GII

**ER:** 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** 0 **KI67:** 15

### Sonomammography:

### Mets Workup:

### History:

55 years old female patient, pre menopausal received tam + zoladex from 8/2021 to 11/2022 >> PD. received AC\*6 with regression then kept on maintenance AI + zometa from 2/2023 to 1/2026.

ct cap 1/2026 + bone scan >> SD but clinically progressed with severe back pain

MRI cervical >> multiple vertebral osseous lesion likely mets with c5+d3 cord compression

recommendation for faslodex + cdk4/6 inhibitor but not received received palliative RTH to C4>D3

### Recommendations:

shifted to faslodex + ibrance

ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

### MDT Outcome & Plan

shifted to faslodex + ibrance

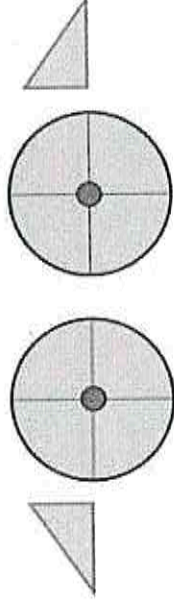
ct cap + MRI whole spine + bone scan as base line in our center

### SIGNATURE

|                                       |         |           |           |           |             |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| MEDICAL ONCOLOGY                      | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
| <p>د. محمد كركاش</p> <p>Signature</p> |         |           |           |           |             |

R

L



TNM



إسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من ..... بشأن تقرير طبي للمريض: حالة

بقسم ..... رقم طبي .....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

رأى السرطان من السرطان و السرطان السرطان

حالة السرطان السرطان السرطان

د د د

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يقتط ،،

إسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

### تقرير طبي

الميد/.....

تحيةة طبية وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من..... بشأن تقرير طبي للمريض: صالح حبيب

بقسم..... رقم طبي.....

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول..... تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

ر/..... سن..... ولابم..... عمل من سنه سنه

ألم حشوي أسفل بطنه يساراً حاداً و.....

تحت

.....

دكتور

تحريراً في

الوقت: ..... التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يتمتع ،،

اسم المريض ثلاثي: .....  
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطلب المقدم من

بقسم

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

Dr. Chabir El-Hariri

علاء الدين

Dr. El-Hariri

تحريراً في

الوقت: / / التاريخ:

الطبيب المعالج

يعتمد

اسم المريض ثلاثي:.....  
رقم الملف:.....

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من

بقسم

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

٢١) السيد حسن ولي الدين السيد خالد  
صبري صاها خان فاروق  
+ بالبريد +

تحريراً في

الوقت: ١ / ١

الطبيب المعالج

يقتد ،،

|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | ملاء حسن العرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

## Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

### Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (4828/23) was received.

### Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;  
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

### Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Micrometastasis: Present.
- Angiolymphatic invasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

### Results:

\* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (score 0+).
- Ki67%: 15%.

### Conclusion:

Left breast cancer, Block revision:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

### IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Ultra low (score 0+).
- Ki67%: 15%.



|                 |                       |                 |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Patient Name    | مالة حسن الزرب        | Case No.        | 357643         |
| Sex/Age         | Female 55 Y           | Patient No.     | 25798          |
| Registered Date | 12/8/2026 11:34:17 AM | Referred By Dr. | Out Patient    |
| Validation Date | 25/8/2026 01:45:54 PM | Branch          | Gustave Roussy |
| Reporting Date  | 14/9/2026 10:59:35 AM | Pathology No.   | SR-930/26      |

**\*\*Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**\*\* Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

**Signature**
**Dr. Walaa Ibrahim Choneim, MD.**


غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر  
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nhar El Qadima - Cairo, Egypt